

CUESTIONARIO DE DISFUNCIÓN SEXUAL SECUNDARIA A PSICOFÁRMACOS

SALSEX / PRSexDQ — Protocolo de Evaluación Clínica

Á. L. Montejo, G. Llorca, J. A. Izquierdo & F. Rico-Villademoros (2000) • Eje VI: Farmacovigilancia y Somática

Paciente / Código:	Edad:	Sexo: ☐ M ☐ F	Fecha:
Evaluador/a:	N.º Historia:	Fármaco/Dosis:	Tiempo en tto.:

CONSIGNA E INSTRUCCIONES CLÍNICAS: Muchos medicamentos utilizados en psiquiatría y medicina pueden influir sobre diferentes aspectos de la vida y respuesta sexual. Con frecuencia los pacientes no mencionan estos cambios por pudor o porque no los relacionan con la medicación.
Instrucción: Las siguientes preguntas exploran si ha experimentado modificaciones en su actividad o deseo sexual desde el inicio o cambio de dosis del tratamiento psicofarmacológico actual en comparación con su estado basal previo. Sus respuestas son estrictamente confidenciales y permiten ajustar el tratamiento para mejorar su calidad de vida.

A. ¿Ha notado alguna alteración sexual desde que toma la medicación?	B. ¿Cómo se comunicó la alteración sexual?
☐ SÍ	☐ Espontáneamente por iniciativa del paciente
☐ NO	☐ Por interrogatorio directo del profesional
☐ No sabe / Sin actividad sexual	☐ No procede (sin alteración)

1 Disminución del Deseo Sexual (Libido)

¿Ha notado menor apetito, interés o ganas de mantener relaciones?

- ☐ 0 = Sin cambios / Deseo habitual
☐ 1 = Leve disminución del deseo
☐ 2 = Moderada disminución del deseo
☐ 3 = Pérdida intensa o total del deseo

2 Retraso en el Orgasmo / Eyaculación

¿Tarda mucho más tiempo del habitual en alcanzar el clímax?

- ☐ 0 = Sin retraso / Tiempo habitual
☐ 1 = Retraso leve (poco molesto)
☐ 2 = Retraso notable y trabajoso
☐ 3 = Retraso severo (muy prolongado)

3 Dificultad o Imposibilidad de Orgasmo (Anorgasmia)

¿Es incapaz de llegar al orgasmo o eyacular?

- ☐ 0 = Alcanza orgasmo normalmente
☐ 1 = Lo alcanza en raras ocasiones
☐ 2 = Falla con mucha frecuencia
☐ 3 = Anorgasmia total / Imposible

4 Disfunción Eréctil o Fallo de Lubricación

Varones: ¿problemas de erección? Mujeres: ¿falta de lubricación?

- ☐ 0 = Erección/lubricación normal
☐ 1 = Leve dificultad inicial
☐ 2 = Moderada (dificulta la relación)
☐ 3 = Severa / Imposibilidad de coito

5 Tolerancia y Riesgo de Abandono del Tratamiento

¿En qué medida le preocupa o le afecta negativamente en su vida?

- ☐ 0 = No le preocupa / No le afecta
☐ 1 = Le preocupa poco / Lo tolera
☐ 2 = Le preocupa bastante / Afecta
☐ 3 = Grave / Se plantea dejar medicación

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Montejo et al., 2000):

- **Puntuación Total SALSEX:** Suma directa de las puntuaciones de los ítems 1 al 5 (Rango: **0 a 15 puntos**).
 - **0 puntos:** Función sexual normal / Sin evidencia de disfunción iatrogénica atribuible al tratamiento.
 - **1 a 5 puntos:** **Disfunción sexual leve.** Monitorización en revisiones ordinarias.
 - **6 a 10 puntos:** **Disfunción sexual moderada.** Requiere intervención terapéutica activa.
 - **11 a 15 puntos:** **Disfunción sexual severa.** Afectación marcada de la calidad de vida y relación de pareja.
- **Alerta Crítica de Incumplimiento Terapéutico:** Una puntuación de **2 o 3 en el ítem 5** constituye bandera roja de riesgo inminente de suspensión unilateral del psicofármaco. Se aconseja reducir dosis, sustitución por fármacos ahorradores (bupropión, vortioxetina, agomelatina, mirtazapina) o adición de coadyuvantes.